



Fecha de Impresión: 07/09/2026 15:53

Centro de atención: Z01 - Zaragoza

Paciente: CC 1042588926 - ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

Fecha de Nacimiento: 29/04/1982

Religión:

Régimen: 2 - Subsidiado

Dirección: BARRIO SAN FRANCISCO CALLE ADELINA COBO

Teléfono: 3167387078

Ocupación: 000: DESEMPLEADOS

Grupo Poblacional:

Acompañante:

Teléfono Acomp.:

Dirección Acomp.:

Responsable:

Teléfono Resp.:

Dirección Resp.:

Médico Tratante: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Atención: 22/04/2024 11:23

Admisión: AD941126

Edad: 41 año(s), 11 mes(es) 24 día(s)

Creencia:

Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.:

Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Impreso por: AMRANDA

Sexo: M

Estado Civil: Soltero

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias

Fecha de Ingreso: 02/04/2024 08:20

Cama: CM845

Motivo de la Consulta:

"TENGO 5 MESES CON FIEBRE "

ANTECEDENTES:

* 1-> DESCRITO

* 2-> TORACOSTOMÍA

* 3-> NIEGA RECIENTE

* 5-> NIEGA ALERGIAS , Ex CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (HACE 6 MESES) , EXFUMADOR MEDIO PAQUETE AL DIA POR 10 AÑOS .

* 6-> ACETAMINOFEN TABLETA POR DOLOR O FIEBRE

Síntesis de la Enfermedad:

paciente quien ingresa por cuadro clínico de 5 meses de evolución consistente en presentar fiebre recurrente , asociado a tos con expectoración verdosa en ocasiones con estigma de sangre , agudizado en los últimos días con disfagia , odinofagia , anorexia , astenia , adinamia , fatiga con el ejercicio , además refiere pérdida de peso (estimada en 8 kg) . niega disuria , úlceras en genitales , dolor pleurítico , disnea , niega cambios en hábitos intestinales , síncope , angor torácico .

PARACLÍNICOS EXTRAINSTITUCIONALES 12 de 03 de 2024 : hemograma (leuco 12.60 , neutro 75 , linf 19 , hb 12.12 , hto 37.5 , rto de plaquetas 609) , uronálisis (no patológico) , ck total 128 , glicemia 99 , Toxoplasma IGG MAYOR 700 , IGM 0.3 , HEPATITIS B NEGATIVO , VDRL positivo reactivo 1 dils .VIH 1 Y2 Negativo , ALT 44 , AST 38 , PCR 225.9 .

Hombre en la quinta década de la vida, con los siguientes problemas:

1. Cursa con síndrome constitucional y síntomas respiratorios de larga evolución, con hallazgos tomográficos en parénquima pulmonar que evidencian cavitación en el ápice derecho así como consolidación neumónica en el segmento anterior del LSD y opacidades reticulonodulares difusas bilaterales por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso. Actualmente bajo sospecha de tuberculosis pulmonar, por lo que se solicitaron pruebas microbiológicas que continúan pendientes (no se han recolectado, se insiste con personal de enfermería). Ante sospecha de sobreinfección bacteriana continua antibioticoterapia prescrita.
2. Presenta debilidad aguda de 12 horas de evolución con paraparesia en miembros inferiores, asociado a hiperreflexia y retención urinaria; sospecho mielopatía, a determinar mielitis transversa, solicito RM de columna cervical, torácica y lumbar; así mismo, solicito tomografía de craneo previo a realización de punción lumbar. Ante la posibilidad de progresión de la debilidad, indico traslado a unidad de cuidados intermedios. Solicito paraclínicos de extensión.
2. Se encuentra en estudio de disfagia tiene endoscopia digestiva superior normal; fue valorado por otorrinolaringología encontrando lesión ulcerada de apariencia tumoral en base de hemilengua derecha con compromiso supraglotico + amputación parcial de la epiglotis + perforación septal, además consideran realización de estudios de extensión para toma de biopsia y análisis de lesión encontrada.
3. Cuenta con prueba de FTA ABS positiva y VDRL reactivo con 8 dils, razón por la que se encuentra prescrito tratamiento como sífilis latente indeterminada. Se explica a paciente y familiar diagnóstico y conducta a seguir, quienes refieren entender y aceptar

Revisión Por Sistema:

a determinar

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

ingresa deambulando por sus medios , en regular estado general , nutricional .

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

Normocefalo cabello de buena implantación , ojos : isocoria normoreactivas a la luz, escleras anictéricas , nariz fosas nasales permeables , boca : mucosa oral

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

húmeda dentadura completa en regular estado , se evidencia a nivel de orofaringe placas hiperémicas , cuello simétrico móvil , no masas , no megalias , no ingurgitación yugular , no rigidez de nuca.

Tórax:

Simétrico expansible, sin tirajes, murmullo vesicular universal disminuido , ruidos cardíacos rítmicos taquicárdico sin soplos.

Abdomen:

Abdomen peristalsis presente , blando depresible no dolor a la palpación superficial y profunda , no masas ni megalias, no signos de irritación peritoneal, puño percusión posterior bilateral negativo.

Piel y faneras:

palidez mucocutánea

Genito-Urinario:

no explorados

Extremidades:

Extremidades simétricas , hipotroficas , sin edema, pulsos periféricos presentes simétricos, llenado capilar menor de 2 segundos

Sistema nervioso central:

glasgow 15 / 15

Análisis:

paciente quien ingresa por cuadro clínico de 6 meses de evolución consistente en presentar fiebre recurrente , asociado a tos con expectoración verdosa en ocasiones con estigma de sangre , agudizado en los últimos días con disfagia , odinofagia , anorexia , astenia , adinamia , fatiga con el ejercicio , además refiere pérdida de peso (estimada en 8 kg) . niega disuria , úlceras en genitales , dolor pleurítico , disnea , niega cambios en hábitos intestinales , síncope , angor torácico .

PARACLÍNICOS EXTRAINSTITUCIONALES 12 de 03 de 2024 : hemograma (leuco 12.60 , neutro 75 , linf 19 , hb 12.12 , hto 37.5 , rto de plaquetas 609) , uroanálisis (no patológico) , ck total 128 , glicemia 99 , Toxoplasma IGG MAYOR 700 , IGM 0.3 , HEPATITIS B NEGATIVO , VDRL positivo reactivo 1 dils .VH 1 Y 2 Negativo , ALT 44 , AST 38 , PCR 225.9 .

paciente en la quinta decada de la vida ,quien ingresa en contexto de síndrome febril recurrente en estudio + sintomático respiratorio + síndrome constitucional , cuenta con paraclinicos extrahospitalarios reciente hemograma con leucocitosis , no neutrofilia , no anemia , trombocitosis ,uroanálisis no patológico , glicemia en metas , toxoplasmosis (pasado , igg positiva e igg negativa) , hepatitis b negativo , vdrl reactivo , serología vih negativo , función hepática conservada , elevación de reactante de fase aguda , considerando clínica de paciente se ordenan paraclinicos institucionales y con resultados determinar conducta a seguir .

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal:

A689 : FIEBRE RECURRENTE, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 1:

Z030 : OBSERVACION POR SOSPECHA DE TUBERCULOSIS

EVOLUCIONES:

Fecha: 02/04/2024: 12:36:54, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: DIEGO ARMANDO ALVEAR FONSECA, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: NOTAMEDICA

Descripción: RX DE TORAX: INFILTRADOS ALGODONOSOS GENERALIZADOS, LESION RADIOPACA EN BASE PULMONAR DERECHA, CUERPO EXTRAÑO EN REGION CLAVICULAR IZQUIERDA.VH: NEGATIVO.HEMOGRAMA: LEUCOCITOS:11250 NEU:74.8 HB:10.6 PLAQUETAS:623000AST: 59 ALT: 39 BUN: 6 BT:0.35 BD:0.10 BI:0.25 CL:95 K:4.3paciente quien ingresa por cuadro clínico de 5 meses de evolución consistente en presentar fiebre recurrente , asociado a tos con expectoración verdosa en ocasiones con estigma de sangre , agudizado en los últimos días con disfagia , odinofagia , anorexia , astenia , adinamia , fatiga con el ejercicio , además refiere pérdida de peso (estimada en 8 kg) . niega disuria , úlceras en genitales , dolor pleurítico , disnea , niega cambios en hábitos intestinales , síncope , angor torácico .se realizan paraclinicos con hemograma donde se observa leucocitosis leve a expensas de neutrofilos anemia leve , trombocitosis , perfil hepático normal, rx de torax con infiltrados algodonsos generalizados con lesion radiopaca en base pulmonar derecha, cuerpo extraño en region clavicular izquierda, vih negativo, por lo anterior se solicita val por medicina interna

Fecha: 03/04/2024: 07:57:18, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JAIME SARMIENTO CALDERON, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Tuberculosis pulmonar presuntiva

2. Sífilis latente indeterminada

3. Desnutrición proteico-calórica

Subjetivo:

comenta pasar buena noche, con mejoría de la disnea, sin presencia de picos febriles recientes, niega nauseas, vomitos, diarrea, hemoptisis u otra sintomatología.

Objetivo:

Signos vitales: PA 100/60 mmHg, FC 91 lpm, FR 18 rpm, T - SpO2 96% a aire ambiente

Aceptable estado general, mal estado musculoesquelético, deambula por sus propios medios.

Piel normocrómica, con lesiones hipopigmentadas en cara y parte posterior del tronco.

Conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, murmullo vesicular disminuido, abolido en base pulmonar derecha, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar Mbtivo De Interconsulta:¿Debilidad en extremidades inferiores?

Enfermedad Actual:Paciente que refiere cuadro de aproximadamente 48 horas de evolución consistente en sensación de debilidad en extremidades inferiores, con limitación a la marcha y la movilidad de las mismas, sin alteración de la sensibilidad. Lo anterior se presenta en contexto de un paciente con síndrome febril de larga data, de inicio en el mes de octubre de 2023, además de disfagia. Ante clínica de déficit neurológico se solicitó interconsulta por nuestra especialidad.Antecedentes:Patológicos: Sífilis tratada en 2013.Farmacológicos: Niega uso frecuente de fármacos.Alérgicos: Niega.Quirúrgicos: Toracostomía cerrada en 2006 por hemotórax secundario a herida por proyectil de arma de fuego.Toxicológicos: Tabaquismo.Examen Físico:Signos Vitales:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

Estables. Regulares condiciones generales, semihidratado, afebril, sin dificultad respiratoria. Presenta lesiones hipocrómicas en piel de cara y tronco, con descamación fina. Neurológico: Alerta, orientado en tres esferas. Lenguaje sin alteración, isocoria 3 mm, normorreactiva, sin oftalmoparesias. Simetría a la mímica facial, resto de pares sin alteración. Mobiliza las extremidades superiores con fuerza 5/5, sensibilidad conservada, reflejos musculotendinosos ++/++++. Las extremidades inferiores presentan fuerza 1/5 de forma bilateral, con sensibilidad conservada y reflejos musculotendinosos ++/++++ del lado derecho, +/++++ el patelar izquierdo, y ++++/++++ el aquiliano izquierdo, con clonus agotable. No presenta meningismo o movimientos anormales. No logra la sedestación por sus propios medios, la bipedestación o la marcha. Glasgow 15 (O: 4 V: 5 M: 6). *** Imágenes ***08-04-2024 TAC de cuello: En columna vertebral se aprecian relaciones articulares conservadas. Hay rectificación de la lordosis fisiológica. Las líneas anatómicas no muestran desviaciones. El canal medular es amplio en toda su extensión. No se aprecian trazos de fractura en elementos óseos. Impresión diagnóstica: - Síndrome medular en estudio - Sospecha de lesión tumoral en base de lengua - Sospecha de tuberculosis pulmonar. Análisis: Paciente masculino de 41 años, con cuadro de síndrome febril y disfagia crónicos, asociando lesión de aspecto tumoral en base de lengua de diagnóstico reciente. Presenta en las últimas 48 horas disminución de fuerza en extremidades inferiores. Al examen físico, se documenta afección motora desde nivel L1 con fuerza 1/5, con reflejos musculotendinosos asimétricos, sin compromiso sensitivo. En el momento no cuenta con imágenes que permitan explorar estructuras del sistema nervioso central para descartar lesiones estructurales. Ya la fueron solicitadas resonancia magnética de columna completa simple y contrastada, sin embargo, se considera pertinente extender estudio a cerebro para descartar principalmente lesiones de naturaleza infecciosa o inflamatoria que pueden cursar con sintomatología descrita por el paciente. Se explica a paciente y familiares, manifiestan entender y aceptar conducta a seguir. Plan De Neurocirugía: - Se solicita: Resonancia magnética cerebral simple y contrastada - Pendiente resonancia magnética de columna cervical, dorsal y lumbosacra simple y contrastada - Resto de manejo por medicina interna

Fecha: 08/04/2024: 15:04:14, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: OSCAR ALFONSO MARRUGO DIAZ, Especialidad: OTORRINOLARINGOLOGIA

Problema:

PACIENTE MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD CON IDX:

1. LESIÓN DE APARIENCIA GRANULOMATOSA EN BASE DE HEMILENGUA DERECHA CON COMPROMISO SUPRAGLÓTICO.

1.1. AMPUTACIÓN PARCIAL DE LA EPIGLOTIS

2. PERFORACIÓN SEPTAL.

2.1. ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

3. TRASTORNO DEGLUTORIO SECUNDARIO

4. SOSPECHA DE TUBERCULOSIS EN ESPERA DE RESULTADOS

5. SÍFILIS LATENTE

6. TOXOPLASMOSIS LATENTE

Subjetivo:

PACIENTE REFIERE PASAR LA NOCHE EN MALAS CONDICIONES POR PRESENCIA DE TOS CON EXPECTORACIÓN. ADEMÁS, REFIERE PERSISTENCIA DE DISFAGIA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON EXACERBADA ODINOFAGIA. TAMBIÉN REFIERE PRESENTAR DEBILIDAD EN MIEMBROS INFERIORES QUE IMPOSIBILITAN LA MARCHA. NIEGA FIEBRE, NIEGA ESCALOFRÍOS, NIEGA OTRA SINTOMATOLOGÍA ADICIONAL.

Objetivo:

PACIENTE EN REGULAR ESTADO GENERAL, ALERTA, ORIENTADO, IMPOSIBILIDAD PARA LA MARCHA.

OTOSCOPIA BILATERAL: CONDUCTOS AUDITIVOS EXTERNOS PERMEABLES, MEMBRANA TIMPÁNICA ÍNTEGRA SIN LESIONES.

RINOSCOPIA ANTERIOR: PRESENCIA DE PERFORACIÓN SEPTAL BIEN DELIMITADA CON MUCOSA SANA, SIN SANGRADO ACTIVO O ESTIGMAS DE SANGRADO, SECRECIONES ESCASAS BILATERALES CORNETES INFERIORES EUTRÓFICOS BILATERAL.

CAVIDAD ORAL Y OROFARINGE: MUCOSA ORAL HÚMEDA SIN LESIONES, PALADAR DURO NORMAL, AMÍGDALAS SIMÉTRICAS.

CUELLO: MOVIL, SIMÉTRICO, SIN MASAS NI MEGALIAS

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 41 AÑOS SIN ANTECEDENTES PATOLÓGICOS CONOCIDOS HOSPITALIZADO POR EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA EN CONTEXTO DE SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR, SÍFILIS LATENTE EN TRATAMIENTO Y TOXOPLASMOSIS. ADEMÁS CURSA CON CUADRO CLÍNICO DE 5 MESES DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN DISFONIA, ODINOFAGIA Y DISFAGIA PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. SE REALIZÓ NASOFIBROLARINGOSCOPIA CON LESIÓN DE ASPECTO GRANULOMATOSO EN BASE DE HEMILENGUA DERECHA CON AMPUTACIÓN PARCIAL DE EPIGLOTIS. ADEMÁS PERFORACIÓN SEPTAL ASOCIADO A TRASTORNO DEGLUTORIO. ACTUALMENTE, PACIENTE EN REGULARES CONDICIONES GENERALES, MALAS CONDICIONES NUTRICIONALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN ESTRIDOR LARÍNGEO, ADECUADA SATURACIÓN OXÍGENO AMBIENTE. EL DÍA DE AYER POR SOSPECHA DE ALTERACIONES NEUROLÓGICAS FOCALES DADAS POR LIMITACIÓN PARA LA MARCHA, CON PÉRDIDA DE FUERZA MUSCULAR EN MIEMBROS INFERIORES Y RETENCIÓN URINARIA EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, SE SOLICITÓ VALORACIÓN POR NEUROCIRUGÍA Y UROLOGÍA, LOS CUALES ESTÁN PENDIENTES. SE CONSIDERÓ INICIALMENTE ESTUDIOS DE EXTENSIÓN PARA DETERMINAR ETIOLOGÍA DE LA LESIÓN DESCRITA, SIN EMBARGO, DEBIDO A CARACTERÍSTICAS GRANULOMATOSAS DE LESIÓN OBSERVADA EN BASE DE LENGUA Y POR SOSPECHA DE ASOCIACIÓN DE ESTA LESIÓN CON DIAGNÓSTICO EN ESTUDIO DE BASE (PROBABLE TB), SE SUSPENDEN POR EL MOMENTO ESTUDIOS DE EXTENSIÓN Y TOMA DE BIOPSIA POR PARTE DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y SE ESPERARÁ A TENER CLARIDAD DE DIAGNÓSTICO DE BASE DEL PACIENTE. POR TRASTORNO DE LA DEGLUCIÓN SE SOLICITARON Y SE ENCUENTRA PENDIENTE VALORACIÓN POR NUTRICIÓN CLÍNICA, FONOAUDIOLOGÍA Y SOPORTE NUTRICIONAL PARA ESTABLECER VÍA DE ALIMENTACIÓN SEGURA. POR LO ANTERIOR, POR NUESTRO SERVICIO, SE CIERRA INTERCONSULTA Y ESTAREMOS ATENTOS A RESULTADOS.

Fecha: 08/04/2024: 15:11:06, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Debilidad aguda no traumática

1.1. Melopatía en estudio

1.2. Melitis transversa a determinar

2. Síndrome febril en estudio

2.1. Tuberculosis pulmonar a confirmar

3. Disfagia en estudio

4. Síndrome constitucional

5. Sífilis indeterminada

6. Anemia leve

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse mal, relata debilidad marcada en miembros inferiores, inicio el día de ayer con episodios de retención urinaria que requirió cateterismo vesical.

Objetivo:

Signos vitales: PA 117/88 mmHg, FC 79 lpm, FR 18 rpm, T 37.1 °C - SpO2 94% a aire ambiente

Mal estado general, desnutrición proteicoenergética grave

Piel normocrómica, con lesiones hipopigmentadas en parte posterior del tronco y cuello.

Conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en buen estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, ruidos respiratorios conservados, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

palpables.

Extremidades simétricas, eutróficas, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar. Paciente con impresión diagnóstica de:- Síndrome medular en estudio- Sospecha de lesión tumoral en base de lengua- Sospecha de tuberculosis pulmonar. Subjetivo: Manifiesta sentirse bien, aunque refiere persistencia de su déficit motor. Examen Físico: Signos Vitales: Estables. Regulares condiciones generales, semihidratado, afebril, sin dificultad respiratoria. Presenta lesiones hipocrómicas en piel de cara y tronco, con descamación fina. Neurológico: Alerta, orientado en tres esferas. Lenguaje sin alteración, isocoria 3 mm, normorreactiva, sin oftalmoparesias. Simetría a la mímica facial, resto de pares sin alteración. Mobiliza las extremidades superiores con fuerza 5/5, sensibilidad conservada, reflejos musculotendinosos ++/++++. Las extremidades inferiores presentan fuerza 1/5 de forma bilateral, con sensibilidad conservada y reflejos musculotendinosos ++/++++ del lado derecho, +/++++ el patelar izquierdo, y ++++/++++ el aquiliano izquierdo, con donus agotable. No presenta meningismo o movimientos anormales. No logra la sedestación por sus propios medios, la bipedestación o la marcha. Glasgow 15 (O: 4 V: 5 M: 6). *** Imágenes *** 08-04-2024 TAC de cuello: En columna vertebral se aprecian relaciones articulares conservadas. Hay rectificación de la lordosis fisiológica. Las líneas anatómicas no muestran desviaciones. El canal medular es amplio en toda su extensión. No se aprecian trazos de fractura en elementos óseos. 08-04-2024 TAC de cráneo: Línea media centrada. La diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca se encuentra conservada. Sistema ventricular y cisternas de la base de amplitud normal. No se aprecian signos que sugieran isquemia o hemorragia en territorio vascular mayor de curso reciente. No se observan colecciones intra o extraaxiales. Cerebelo y demás estructuras de la fosa posterior sin alteraciones patológicas. Las estructuras óseas presentan densidad normal. Tejidos blandos periféricos de densidad y grosor normal. Conclusión: Estudio dentro de límites de la normalidad. Análisis: Paciente masculino de 41 años, con cuadro de síndrome febril y disfagia crónicos, asociando lesión de aspecto tumoral en base de lengua de diagnóstico reciente. Presenta en las últimas 48 horas disminución de fuerza en extremidades inferiores. Al examen físico, se documenta afección motora desde nivel L1 con fuerza 1/5, con reflejos musculotendinosos asimétricos, sin compromiso sensitivo. Dado que aún no cuenta con estudios imagenológicos para descartar lesiones estructurales en sistema nervioso central, se decide dar cierre de seguimiento por nuestra especialidad y se revalorará cuando cuente con estudios de resonancia solicitados. Plan:- Cierre de seguimiento por neurocirugía.- Atentos a llamado con resultado de resonancias simple y contrastada de cerebro y eje espinal completo.

Fecha: 09/04/2024: 17:23:05, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: EDINSON JAMER GUETO ALCALA, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE SIFILIS EN 2013 (TRATADA), TABAQUISTA, QUE INGRESA A UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, DADO A ALTO RIESGO DE PROGRESIÓN DE PARESIA, EN CONTEXTO DE:

1. SÍNDROME NEUROLÓGICO EN ESTUDIO SECUNDARIO:

1.1 SÍNDROME DE MOTONEURONA INFERIOR, PROBABLE MILOPATIA DESMELINIZANTE, EN SOSPECHA DE MELITIS TRANSVERSA TENIENDO EN CUENTA HALLAZGOS CLÍNICOS DE ARREFLEXIA, FLACIDEZ, ATONÍA DE ESFÍNTER VESICAL Y ANAL, Y NISTAGMUS HORIZONTAL AGOTABLE. A ESPERA DE RMN DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL CONTRASTADA PARA CONFIRMAR DIAGNÓSTICO.

1.2 NEUROINFECCIÓN, MENOS PROBABLE CON HALLAZGOS EN LCR DE HIPOGLUCORRUEA Y ADA POR ENCIMA DEL PUNTO DE CORTE INSTITUCIONAL (5.0) POR LO QUE NO SE DESCARTA TUBERCULOSIS MENINGEA. EN MANEJO ESTEROIDE ENDOVENOSO.

2. TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNÓSTICO CLÍNICO E IMAGENOLÓGICO, SOBREENFECTADA POR NEUMONÍA BACTERIANA. TOMOGRAFÍA DE TÓRAX REPORTA CAVITACIÓN EN EL APICE DERECHO, OPACIDADES RETICULONODULARES BILATERALES POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO Y CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA EN LSD. RECIBE MANEJO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA SULBACTAM Y CLARITROMICINA. PENDIENTE BACILOSCOPIAS SERIADAS, CULTIVO Y PCR PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN ESPUTO. ADEMÁS INICIO DE TERAPIA RIPE.

3. SIFILIS LATENTE INDETERMINADA, CON REPORTE DE VDRL REACTIVO EN 8 DILS, FTA ABS POSITIVO, QUIEN YA RECIBIÓ PRIMERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA, PRÓXIMA DOSIS (10/04/24).

4. DISFAGIA EN ESTUDIO

4.1 TUMOR ULCERADO EN BASE DE HEMILENGUA DERECHA CON COMPROMISO SUPRAGLOTICO Y AMPUTACIÓN PARCIAL DE LA EPIGLOTIS Y PERFORACIÓN SEPTAL POR NASOFIBROLARINGOSCOPIA, A LA ESPERA DE BIOPSIA POR MICROENDOSCOPIA LARÍNGEA, AHORA DIFERIDA POR DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS.

DE MOMENTO PACIENTE AFEBRIL, NEUROLÓGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, GLASGOW 15, HEMODINÁMICAMENTE EUCÁRDICO EN RITMO DE BASE SINUSAL, CIFRAS TENSIONALES EN META SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVOS, BUEN PATRÓN VENTILATORIO SIN OXÍGENO POR DISPOSITIVOS, CON OXIMETRÍAS EN META AL VISOSCOPIO, DIURESIS PRESENTE EN SONDAS VESICAL. BUEN CONTROL METABOLICO.

DURANTE LA TARDE DE HOY SIN CAMBIOS ADICIONALES A MANEJO, ATENCIÓN A EVOLUCIÓN CLÍNICA.

AMERITA SEGUIMIENTO POR TERAPIA FÍSICA 2 VECES AL DÍA Y SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLICO.

Fecha: 09/04/2024: 22:41:43, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: CHRISTIAN ORLANDO BUELVAS ALVÍS, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE SIFILIS EN 2013 (TRATADA), TABAQUISTA, QUE INGRESA A UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, DADO A ALTO RIESGO DE PROGRESIÓN DE PARESIA, EN CONTEXTO DE:

1. SÍNDROME NEUROLÓGICO EN ESTUDIO SECUNDARIO:

1.1 SÍNDROME DE MOTONEURONA INFERIOR, PROBABLE MILOPATIA DESMELINIZANTE, EN SOSPECHA DE MELITIS TRANSVERSA TENIENDO EN CUENTA HALLAZGOS CLÍNICOS DE ARREFLEXIA, FLACIDEZ, ATONÍA DE ESFÍNTER VESICAL Y ANAL, Y NISTAGMUS HORIZONTAL AGOTABLE. A ESPERA DE RMN DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL CONTRASTADA PARA CONFIRMAR DIAGNÓSTICO, PROGRAMADA PARA EL DÍA DE MAÑANA A LAS 2 PM.

1.2 NEUROINFECCIÓN, MENOS PROBABLE CON HALLAZGOS EN LCR DE HIPOGLUCORRUEA Y ADA POR ENCIMA DEL PUNTO DE CORTE INSTITUCIONAL (5.0) POR LO QUE NO SE DESCARTA TUBERCULOSIS MENINGEA. EN MANEJO ESTEROIDE ENDOVENOSO.

2. TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNÓSTICO CLÍNICO E IMAGENOLÓGICO, SOBREENFECTADA POR NEUMONÍA BACTERIANA. TOMOGRAFÍA DE TÓRAX REPORTA CAVITACIÓN EN EL APICE DERECHO, OPACIDADES RETICULONODULARES BILATERALES POR PROCESO INFLAMATORIO CRÓNICO DE ORIGEN GRANULOMATOSO Y CONSOLIDACIÓN NEUMÓNICA EN LSD. RECIBE MANEJO ANTIBIÓTICO CON AMPICILINA SULBACTAM Y CLARITROMICINA. PENDIENTE BACILOSCOPIAS SERIADAS, CULTIVO Y PCR PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN ESPUTO. ADEMÁS INICIO DE TERAPIA RIPE.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

3. SIFILIS LATENTE INDETERMINADA, CON REPORTE DE VDRL REACTIVO EN 8 DILS, FTA ABS POSITIVO, QUIEN YA RECIBIÓ PRIMERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA, PROXIMA DOSIS (10/04/24).

4. DISFAGIA EN ESTUDIO

4.1 TUMOR ULCERADO EN BASE DE HEMILENGUA DERECHA CON COMPROMISO SUPRAGLOTICO Y AMPUTACION PARCIAL DE LA EPIGLOTIS Y PERFORACION SEPTAL POR NASOFIBROLARINGOSCOPIA, A LA ESPERA DE BIOPSIA POR MICROENDOSCOPIA LARINGEA, AHORA DIFERIDA POR DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS.

DE MOMENTO PACIENTE AFEBRIL, NEUROLOGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, GLASGOW 15, HEMODINAMICAMENTE EUCARDICO EN RITMO DE BASE SINUSAL, CIFRAS TENSIONALES EN META SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVOS, BUEN PATRON VENTILATORIO SIN OXIGENO POR DISPOSITIVOS, CON OXIMETRIAS EN META AL VISOSCOPIO, DIURESIS PRESENTE EN Sonda VESICAL. BUEN CONTROL METABOLICO.

DURANTE LA NOCHE DE HOY SIN CAMBIOS ADICIONALES A MANEJO, ATENCIÓN A EVOLUCIÓN CLÍNICA.

AMERITA SEGUIMIENTO POR TERAPIA FÍSICA 2 VECES AL DÍA Y SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLICO.

Fecha: 10/04/2024: 09:48:30, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: CHRISTIAN ORLANDO BUELVAS ALVIS, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 41 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE SIFILIS EN 2013 (TRATADA), TABAQUISTA, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS ANTE RIESGO DE DETERIORO NEUROLOGICO PROGRESIVO QUE LIMITE LA CAPACIDAD DE PROTEGER VIA AEREA. ACTUALMENTE EN CONTEXTO DE:

1. SINDROME NEUROLOGICO EN ESTUDIO SECUNDARIO:

1.1 SINDROME DE MOTONEURONA INFERIOR, PROBABLE MIELOPATIA DESMELINIZANTE, EN SOSPECHA DE MELITIS TRANSVERSA TENIENDO EN CUENTA HALLAZGOS CLINICOS, A ESPERA DE RMN DE COLUMNA VERTEBRAL TOTAL CONTRASTADA PARA CONFIRMAR DIAGNOSTICO, PROGRAMADA EL DIA DE HOY.

1.2 NEUROINFECCION, MENOS PROBABLE CON HALLAZGOS EN LCR DE HIPOGLUCORRUIA Y ADA POR ENCIMA DEL PUNTO DE CORTE INSTITUCIONAL (5.0) POR LO QUE NO SE DESCARTA TUBERCULOSIS MENINGEA. EN MANEJO ESTEROIDE ENDOVENOSO.

2. TUBERCULOSIS PULMONAR POR DIAGNOSTICO CLÍNICO E IMAGENOLÓGICO, SOBREENFECTADA POR NEUMONÍA BACTERIANA. RECIBE MANEJO ANTIBIOTICO CON AMPICILINA SULBACTAM Y CLARITROMICINA Y TERAPIA RIPE. PRIMERA BACILOCOPIA POSITIVA PARA BAAR, PENDIENTE BACILOSCOPIA 2 Y 3, CULTIVO Y PCR PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN ESPUTO.

3. SIFILIS LATENTE INDETERMINADA, CON REPORTE DE VDRL REACTIVO EN 8 DILS, FTA ABS POSITIVO, QUIEN YA RECIBIÓ PRIMERA DOSIS DE PENICILINA BENZATINICA, PROXIMA DOSIS (10/04/24).

4. DISFAGIA EN ESTUDIO

4.1 TUMOR ULCERADO EN BASE DE HEMILENGUA DERECHA CON COMPROMISO SUPRAGLOTICO Y AMPUTACION PARCIAL DE LA EPIGLOTIS Y PERFORACION SEPTAL POR NASOFIBROLARINGOSCOPIA, A LA ESPERA DE BIOPSIA POR MICROENDOSCOPIA LARINGEA, AHORA DIFERIDA POR DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS.

DE MOMENTO PACIENTE AFEBRIL, NEUROLOGICAMENTE CONSCIENTE, ALERTA, GLASGOW 15, HEMODINAMICAMENTE EUCARDICO EN RITMO DE BASE SINUSAL, CIFRAS TENSIONALES EN META SIN REQUERIMIENTO DE SOPORTE VASOACTIVOS, REGULAR PATRON VENTILATORIO SIN OXIGENO POR DISPOSITIVOS, CON OXIMETRIAS EN META AL VISOSCOPIO, DIURESIS PRESENTE EN Sonda VESICAL. BUEN CONTROL METABOLICO, ULTIMAS GLUCOMETRIAS: 142-129 MG/DL.

10/04/24

TP 10.8/10.6 INR 1.1 TPT 27.8/26.7

LEU 12910 NEU 85% HB 10.7 HTO 33.6% PLT 499000

BUN 12 CREAT 0.64

CL 104 NA 138 K 4.7 P 3.6 MG 2.2 CAI 1.2

PARACLINICOS DEL DIA REPORTAN TIEMPOS DE COAGULACION SIN PROLONGACION, LIGERA LEUCOCITOSIS, NEUTROFILIA, ANEMIA LEVE Y PLAQUETAS NORMALES, FUNCION RENAL Y IONOGRAMA SIN ALTERACION.

EL DIA DE HOY AJUSTO FLUIDOTERAPIA EN ARAS DE DISMINUIR RIESGO DE SOBRECARGA HIDRICA. DEBE PERMANECER BAJO MANEJO INSTAURADO SIN CAMBIOS ADICIONALES, PRONOSTICO Y CONDUCTAS SUJETAS A EVOLUCION CLINICA.

AMERITA SEGUIMIENTO POR TERAPIA FÍSICA 2 VECES AL DÍA Y SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLICO.

Fecha: 11/04/2024: 12:13:18, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedentes de sifilis en 2013 (tratada), tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico en estudio secundario:

1.1 síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa teniendo en cuenta hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética de columna vertebral total contrastada para confirmar diagnóstico, por proyectiles de arma en pecho, pendiente valoración por neurología.

1.2 neuroinfección, menos probable con hallazgos en lcr de hipoglucorraquia y ada por encima del punto de corte institucional (5.0) por lo que no se descarta tuberculosis meningea. En manejo esteroide endovenoso.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico e imagenológico, sobreinfectada por neumonía bacteriana. Recibe manejo antibiótico con ampicilina sulbactam y claritromicina y terapia ripe. Primera baciloscopia positiva para baar, pendiente baciloscopia 2 y 3, cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente indeterminada, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, quien ya recibió primera y segunda dosis de penicilina benzatínica, próxima y última dosis (17/04/24).

4. Disfagia en estudio

4.1 tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea, ahora diferida por diagnóstico de tuberculosis.

De momento paciente afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15, hemodinamicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos, regular patrón ventilatorio sin oxígeno por dispositivos, con oximetrías en meta al visoscopio, diuresis presente en sonda vesical con gasto urinario de: 1.8 cc/kg/hora. Buen control metabólico, últimas glucometrías: 182-83 mg/dL.

De momento sin cambios adicionales al manejo médico, amerita seguimiento por terapia física 2 veces al día y soporte nutricional y metabólico.

Fecha: 11/04/2024: 16:27:45, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ALFONSO FRIAS SALAZAR, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética de columna vertebral total contrastada para confirmar diagnóstico por presencia de proyectiles de arma en tórax; pendiente valoración por neurología.

1.2 Neuroinfección menos probable, con hallazgos en lcr de hipogluorraquia y ada en valor superior a punto de corte institucional (5.0), por lo que no se descarta tuberculosis meningea. En manejo con esteroide endovenoso.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico imagenológico y microbiológico, sobreinfectada por neumonía bacteriana.

*En manejo antibiótico con ampicilina/sulbactam hasta el día de hoy y claritromicina.

*Recibe además terapia ripe.

*Cuenta con primera baciloscopias #1-2 positiva para baar, pendiente #3, cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente indeterminada, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, quien ya recibió primera y segunda dosis de penicilina benzatínica, próxima y última dosis para el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea, ahora diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la tarde encuentro paciente afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15, hemodinamicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos, regular patrón ventilatorio sin oxígeno por dispositivos, con oximetrías en meta al visoscopio, diuresis presente en sonda vesical con gasto urinario de: 1.8 cc/kg/hora; tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías: 82-81-105 mg/dL.

Continúa en vigilancia estricta; de momento sin cambios adicionales al manejo médico, amerita seguimiento por terapia física 2 veces al día y soporte nutricional y metabólico.

Fecha: 12/04/2024: 12:13:14, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética de columna vertebral total contrastada para confirmar diagnóstico por presencia de proyectiles de arma en tórax; pendiente valoración por neurología.

1.2 Neuroinfección menos probable, con hallazgos en lcr de hipogluorraquia y ada en valor superior a punto de corte institucional (5.0), por lo que no se descarta tuberculosis meningea. En manejo con esteroide endovenoso.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico imagenológico y microbiológico(BK de esputo #1-2-3 positivo), sobreinfectada por neumonía bacteriana, completo cubrimiento antibiótico con ampicilina/sulbactam + claritromicina, recibe además terapia ripe, pendiente cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente indeterminada, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, quien ya recibió primera y segunda dosis de penicilina benzatínica, próxima y última dosis para el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea, ahora diferida por diagnóstico de tuberculosis.

actualmente paciente en aceptables condiciones generales, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15, hemodinamicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos, regular patrón ventilatorio sin oxígeno por dispositivos, con oximetrías en meta al visoscopio, diuresis presente en sonda vesical con gasto urinario de: 1.8 cc/kg/hora; tolera vía oral con buen control metabólico, afebril

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

Continúa en vigilancia estricta; de momento sin cambios adicionales al manejo médico, amerita seguimiento por terapia física 2 veces al día y soporte nutricional y metabólico.

Fecha: 13/04/2024: 15:53:26, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO JESUS GONZALEZ FERNANDEZ, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLÍNICOS: 13/04/2024 Hemograma: leucos: 11.67 neutro:77.3% linf:13.6% hb:9.7 hto: 30.5% plt: 448.000

Bun:13 cr:0.47 cl: 102 k:4.5 na:137

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de para confirmar diagnóstico por presencia de proyectiles de arma en tórax; pendiente valoración por neurología, se considera solicitar tomografía de columna completa con contraste para evaluar compromiso.

1.2 Neuroinfección menos probable, con hallazgos en lcr de hipogluorraquia y ada en valor superior a punto de corte institucional (5.0), por lo que no se descarta tuberculosis meningea. En manejo con esteroide endovenoso.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico imagenológico y microbiológico, sobreinfectada por neumonía bacteriana tratada.

*Recibe además terapia ripe.

*Cuenta con primera baciloscopias #1-2 positiva para baar, pendiente #3, cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente indeterminada, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, quien ya recibió primera y segunda dosis de penicilina benzatínica, próxima y última dosis para el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea, ahora diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la mañana encuentro paciente afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15, hemodinamicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos, regular patrón ventilatorio sin oxígeno por dispositivos, con oximetrías en meta al visoscopio, diuresis presente en sonda vesical con gasto urinario de: 2.5 8 cc/kg/hora; tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías: 82-81-105 mg/dL.

-Paraclinicos control con leucocitosis leve, anemia moderada, resto normal.

Continúa en vigilancia estricta; de momento sin cambios adicionales al manejo médico, amerita seguimiento por terapia física 2 veces al día y soporte nutricional y metabólico.

Fecha: 14/04/2024: 11:56:16, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: BRENDA VILLALOBOS RENTERIA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de para confirmar diagnóstico por presencia de proyectiles de arma en tórax; pendiente valoración por neurología, se considera solicitar tomografía de columna completa con contraste para evaluar compromiso.

1.2 Neuroinfección menos probable, con hallazgos en lcr de hipogluorraquia y ada en valor superior a punto de corte institucional (5.0), por lo que no se descarta tuberculosis meningea. En manejo con esteroide endovenoso.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas). Recibe terapia ripe, espera cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea, ahora diferida por diagnóstico de tuberculosis.

Paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15, hemodinamicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos, regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio, diuresis presente, tolera vía oral con buen control metabólico.

Continua manejo medico, se ajustara terapia de acuerdo a evolucion.

Fecha: 14/04/2024: 14:17:27, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: BRENDA VILLALOBOS RENTERIA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de para confirmar diagnóstico por presencia de proyectiles de arma en tórax; pendiente valoración por neurología, se considera solicitar tomografía de columna completa con contraste para evaluar compromiso.

1.2 Neuroinfección menos probable, con hallazgos en lcr de hipogluorraquia y ada en valor superior a punto de corte institucional (5.0), por lo que no se descarta tuberculosis meningea. En manejo con esteroides endovenoso.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas). Recibe terapia ripe, espera cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea, ahora diferida por diagnóstico de tuberculosis.

Paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15, hemodinámicamente compensado eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos, regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio, diuresis presente, tolera vía oral con buen control metabólico.

Continúa manejo médico, se ajustará terapia de acuerdo a evolución. Familiares condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución.

Fecha: 15/04/2024: 11:20:33, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLÍNICOS: 15/04/2024 Hemograma: leucos: 11.23 neutro: 73.3% linf: 18.1% hb:10.2 hto: 32.4% plt:497.000

Bun:9 cr: 0.53

Cl:100 k:4.8 Na:135

CULTIVO: negativo a las 48 horas - final.

Herpes virus I igG negativo

Herpes virus II igG pendiente.

-ziehl neelsen (esputo): no se observan baar en 100 campos analizados.

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de para confirmar diagnóstico por presencia de proyectiles de arma en tórax; pendiente valoración por neurología, pendiente realización de tomografía de columna completa con contraste para evaluar compromiso.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo terapia Ripe, espera cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea, ahora diferida por diagnóstico de tuberculosis.

Durante ronda médica de la mañana en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15, hemodinámicamente compensado eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos, regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio, diuresis presente, tolera vía oral con buen control metabólico.

-Paradclínicos control con leucocitosis, anemia moderada, resto normal.

Continúa manejo médico, se ajustará terapia de acuerdo a evolución. Familiares, condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución.

Fecha: 15/04/2024: 17:55:37, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** ALVARO ALFONSO FRIAS SALAZAR, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; pendiente valoración por neurología y tomografía contrastada de columna completa para evaluar compromiso.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo terapia RIPE, espera cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la tarde encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente taquicárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con referencia de buen ritmo, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 142-110-97 mg/dl.

Continúa en vigilancia estricta; a espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas, de momento sin cambios adicionales al manejo médico, se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución.

Fecha: 16/04/2024: 12:50:30, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

PARACLÍNICOS: 16/04/20254 **sin paraclínicos control para reportar
ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; tomografía contrastada de columna completa para evaluar compromiso.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo terapia RIPE, espera cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la mañana encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente taquicárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con referencia de buen ritmo, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 142-110-97 mg/dL.

Continúa en vigilancia estricta; a espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas, de momento sin cambios adicionales al manejo médico, se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución.

Fecha: 16/04/2024: 17:42:11, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** ALVARO ALFONSO FRIAS SALAZAR, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; a espera de imagen y reporte oficial de tomografía contrastada de columna completa para valorar compromiso.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo terapia RIPE; pendiente cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la tarde encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente taquicárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con referencia de buen ritmo, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 142-110-97-103 mg/dL.

Continúa en vigilancia estricta; a espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas, de momento sin cambios adicionales al manejo médico, se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución.

Fecha: 17/04/2024: 13:47:03, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** JUAN PABLO ORTIZ SALAZAR, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLÍNICOS: 17/04/20254 **sin paraclínicos control para reportar .

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; a espera de imagen y reporte oficial de tomografía contrastada de columna completa para valorar compromiso.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo terapia RIPE; pendiente cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

En ronda de la mañana encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente taicárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con referencia de buen ritmo, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 100 mg/dL.

Continúa en vigilancia estricta; a espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas, de momento sin cambios adicionales al manejo médico, se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución.

Fecha: 17/04/2024: 17:45:38, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** ALVARO ALFONSO FRIAS SALAZAR, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; a espera de imagen y reporte oficial de tomografía contrastada de columna completa para valorar compromiso.

*Pendiente valoración por neurología para definir realización de estudios de neurofisiología.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

*Pendiente re-valoración por infectología para apoyo terapéutico, con toxoplasmosis con igm positivo.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo con terapia RIPE; pendiente cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la tarde encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con referencia de buen ritmo, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 103-111 mg/dL.

Continúa en vigilancia estricta; a espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas y valoración por especialidades, de momento sin cambios adicionales al manejo médico, se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución.

Fecha: 18/04/2024: 14:37:13, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLÍNICOS: 18/04/20254 **sin paraclínicos control para reportar .

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en la unidad de cuidados intermedios en contexto de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; a espera de imagen y reporte oficial de tomografía contrastada de columna completa para valorar compromiso.

*Valorado por neurología quien solicita resonancia magnética.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

*Pendiente re-valoración por infectología para apoyo terapéutico, con toxoplasmosis con igm positivo.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo con terapia RIPE; pendiente cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente, con reporte de vdrl reactivo en 8 dils, fta abs positivo, en manejo con penicilina benzatínica, pendiente tercera dosis el 18/04/24.

4. Disfagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la mañana encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con referencia de buen ritmo, tolera vía oral con buen control metabólico dado por última glucometría en 129 mg/dL.

A espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas y valoración por especialidades, de momento sin cambios adicionales al manejo médico, se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución, se traslada a sala general para continuar manejo.

Fecha: 19/04/2024: 14:08:08, **Historia:** Evolucion Clinica UCI, **Prestador:** ALVARO ALFONSO FRIAS SALAZAR, **Especialidad:** CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLÍNICOS: 19/04/2024 Hemograma: leucos: 13.52 neutro: 80.9% linfo: 11.7 hb: 11.5 hto: 36% plt: 542.000

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

Bun:14 cr:0.54 Cl:95 k:5.0 na:131

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en sala general- aislado ante diagnósticos de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; a espera de imagen y reporte oficial de tomografía contrastada de columna completa para valorar compromiso.

*Se solicita revalorado por neurología con imágenes de tomografía de columna completa contrastada.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

*Valorado por infectología quienes consideran ante resultados de IgM sérica positiva para toxoplasma se consideró diagnóstico sin embargo con evidencia de tomografía de cráneo sin lesiones sugestivas además sin síndrome clínico concordante con toxoplasmosis por lo que se descarta diagnóstico, de igual forma se realizó pruebas microbiológicas que descartan neurotuberculosis

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo con terapia RIPE; pendiente cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente tratado completando tres dosis de penicilina benzatínica.

4. Odinofagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda de la mañana encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con referencia de buen ritmo, tolera vía oral con buen control metabólico dado por última glucometría en 97 mg/dL.

A espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas y valoración por especialidades, se suspende omeprazol y resto de manejo sin cambios adicionales se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución, pendiente sala general para continuar manejo.

Fecha: 20/04/2024: 12:45:49, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: WILLIAM YAMITH CASTRO MENDOZA, Especialidad: CIRUGIA GENERAL

Análisis:

PARACLÍNICOS 20/04/2024: sin control para el reporte de hoy.

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en sala general- aislado ante diagnósticos de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; a espera de imagen y reporte oficial de tomografía contrastada de columna completa para valorar compromiso.

*Pendiente re valoración por neurología con imágenes de tomografía de columna completa contrastada.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo con terapia RIPE; pendiente cultivo y pcr para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente tratado completando tres dosis de penicilina benzatínica.

4. Odinofagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laringea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda médica encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con gasto urinario de 2.0 cc/kg/h, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 129-97-104 mg/dL.

A espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas y valoración por especialidades, resto de manejo sin cambios adicionales se ajustará de acuerdo a evolución. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución, pendiente traslado a sala general para continuar manejo.

Fecha: 21/04/2024: 12:06:26, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: SAID CLARETE DE LAROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

PARACLÍNICOS 21/04/2024: sin control para el reporte de hoy.

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en sala general- aislado ante diagnósticos de:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; a espera de reporte oficial de tomografía contrastada de columna completa para valorar compromiso.

*Pendiente re valoración por neurología con imágenes para definir nuevas conductas.

1.2 Neuroinfección descartada con cultivo de lcr negativo a las 48 horas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo con terapia RIPE; pendiente cultivo y por para mycobacterium tuberculosis en esputo.

3. Sífilis latente tratada, completó tres dosis de penicilina benzatínica.

4. Odinofagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda médica encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con gasto urinario de 2.0 cc/kg/h, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 97-104-99 mg/dL.

A espera de estudios de extensión para definir nuevas conductas y valoración por especialidades, resto de manejo sin cambios adicionales. Familiares informados sobre condición clínica actual, pronóstico sujeto a evolución. Pendiente traslado a sala general para continuar manejo.

Fecha: 21/04/2024: 15:47:41, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: SAID CLARETE DE LA ROSA, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Análisis:

*****NOTA ADICIONAL*****

TAC DE COLUMNA CERVICAL CONTRASTADA

Los cuerpos vertebrales presentan altura y alineación normales, sin evidencia de lesiones traumáticas. Se demuestra canal amplio y suficiente, saco dural satisfactorio, raíces nerviosas libres en su salida, con agujeros de conjugación normales, facetas articulares sin alteraciones. Unión craneocervical sin alteraciones. Los discos intervertebrales se muestran normales, sin evidencia de abombamientos ni herniaciones. Grasa epidural y ligamentos amarillos así como las estructuras vasculares se observaron normales.

TAC DE COLUMNA TORACICA CONTRASTADA

El estudio demuestra que la altura de los discos intervertebrales de los segmentos valorados se encuentran conservadas. Los cuerpos vertebrales presentan altura y alineación normales, sin evidencia de lesiones traumáticas. Los diámetros del canal raquídeo son amplios y se observa de manera adecuada la médula espinal y las raíces emergentes. Se identifica de manera adecuada el cordón medular, la cauda equina no evidenciándose lesiones intra-axiales o colecciones extra-axiales. Se mencionan opacidades reticulonodulares difusas bilaterales con cavitaciones en ambos ápices pulmonares por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso. Mínima cantidad de líquido pleural derecho y engrosamiento pleural derecho.

TAC DE COLUMNA LUMBAR CONTRASTADA

En todos los segmentos valorados la altura y la alineación de los cuerpos vertebrales se encuentran conservadas. Los discos intervertebrales presentan morfología y altura normal, no existiendo signos de hernias discales. El saco dural y su contenido se visualizan adecuadamente así como las emergencia de las raíces. La grasa peridural está conservada. No hay signos de enfermedad de las facetas articulares. Los diámetros del canal son normales; la amplitud de los recesos laterales y los agujeros de conjugación es adecuada. No hay evidencia de lisis ni de listesis.

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en sala general- aislado ante diagnósticos de:

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax.

Se recibe reporte de tomografía contrastada de columna completa que descarta compromiso medular, por lo cual solicito estudios de neuroconducción+ electromiografía de miembros inferiores en búsqueda de afectación de nervio periférico.

Fecha: 22/04/2024: 11:19:29, Historia: Evolucion Clinica UCI, Prestador: ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL, Especialidad: CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO CRITICO

Análisis:

PARACLÍNICOS 22/04/2024: Hemograma: coagulada.

Bun:8 Cr: 0.35

Cl:99 k:4.9 Na:131

IMÁGENES

16/04/2024 TAC DE COLUMNA CERVICAL CONTRASTADA

Los cuerpos vertebrales presentan altura y alineación normales, sin evidencia de lesiones traumáticas. Se demuestra canal amplio y suficiente, saco dural satisfactorio, raíces nerviosas libres en su salida, con agujeros de conjugación normales, facetas articulares sin alteraciones. Unión craneocervical sin alteraciones. Los discos intervertebrales se muestran normales, sin evidencia de abombamientos ni herniaciones. Grasa epidural y ligamentos amarillos así como las estructuras vasculares se observaron normales.

ANÁLISIS:

Paciente masculino de 41 años de edad con antecedente de sífilis en 2013 (tratada) y tabaquismo, con estancia actual en sala general- aislado ante diagnósticos de:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 3:51:32 p. m.

Admisión: AD941126

Administradora: SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

Paciente: ALBERTO HERNANDEZ BARRIOS

EPICRISIS

1. Síndrome neurológico agudo en estudio secundario a:

1.1 Síndrome de motoneurona inferior, probable mielopatía desmielinizante, en sospecha de mielitis transversa ante hallazgos clínicos, con imposibilidad de realización de resonancia magnética para confirmar diagnóstico dada presencia de proyectiles de arma en tórax; con reporte de tomografía de columna sin hallazgos.

*Pendiente realización de estudios de neuroconducción y electromiografía de miembros inferiores y re valoración por neurología con imágenes para definir nuevas conductas.

2. Tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, imagenológico y microbiológico (baciloscopias positivas), en manejo con terapia RIPE; pendiente cultivo y por para mycobacterium tuberculosis en esputo.

4. Odinofagia en estudio, con documentación de tumor ulcerado en base de hemilengua derecha con compromiso supraglótico y amputación parcial de la epiglotis y perforación septal por nasofibrolaringoscopia, a la espera de biopsia por microendoscopia laríngea; de momento diferida por diagnóstico de tuberculosis.

En ronda médica encuentro paciente en regular estado general, afebril, neurológicamente consciente, alerta, glasgow 15/15; hemodinámicamente eucárdico en ritmo de base sinusal, cifras tensionales en meta sin requerimiento de soporte vasoactivos; regular patrón ventilatorio sin oxígeno suplementario, con oximetrías en meta al visoscopio; diuresis presente con gasto urinario de 2.6 cc/kg/h, tolera vía oral con buen control metabólico dado por últimas glucometrías en 98 mg/dL.

-Función renal e ionograma sin alteración.

Se considera dar egreso médico con manejo establecido, además de cita control por neurología, fonoaudiología, otorrinolaringología, infectología y estudios de extensión. Se dan recomendaciones y signos de alarma.

Procedimientos Realizados y Ordenados:**Medicamentos Ordenados y Administrados:****Medidas Generales Ordenadas:****Justificación de indicaciones Terapéuticas:****Complicaciones:**

Sin complicaciones

Servicio de Egreso: 000034|Hospitalización Gral 9no Piso

Fecha de Egreso: 22/04/2024 11:19

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: G992 : MELOPATIA EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE

Diagnóstico Relacionado 1: A153 : TUBERCULOSIS DEL PULMON , CONFIRMADA POR MEDIOS NO ESPECIFICADOS

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:**Tratamiento Farmacológico:**

Ver hc

Recomendaciones Adicionales:

Ver hc

Aplica Cuidados de Enfermería: No

ALVARO ANDRES ZAPATA LEAL
CUIDADO DEL PACIENTE EN ESTADO
CRITICO

CC.79691937 - RM.79691937